Esófago, estómago y úlcera péptica

SEMIOLOGIA · Clase 22 · pirosis, disfagia, úlcera y sus complicaciones, síndrome pilórico

1 · ESÓFAGO: CÓMO SE TRAGA

Pirosis F9
ardor retroesternal que asciende hasta la faringe por reflujo; peor acostado de noche

mejora con

Mejora cenando temprano y elevando la cabecera; la acidez simple se queda en el epigastrio

Disfagia F10
dificultad para que el bolo pase; p. ej. tumor que estrecha la luz

si es un divertículo

Divertículo de Zenker F12
bolsillo del esófago donde el alimento se descompone: halitosis digestiva

Odinofagia F11
dolor al deglutir, aunque el bolo pase

se estudia con

se estudia con

Bario o endoscopia F10 · F11
localizan la estenosis; el bario se contraindica si se sospecha perforación

2 · ÚLCERA PÉPTICA: POR QUÉ DUELE Y DÓNDE SE FORMA

Células parietales (🔁) F8
glándulas del fondo: producen ácido clorhídrico y factor intrínseco

el ácido ahonda la pared:

Úlcera péptica F3
cráter en estómago o duodeno; más en la primera porción del duodeno y en varones

al ahondarse da

Dolor terebrante F1
el cráter se ahonda como un taladro; a veces urente

su ritmo con la comida

Dolor y comida (🔁) F2
gástrica: aumenta al comer; duodenal: alivia (dolor de hambre)

a la palpación muestra

Punto epigástrico
mitad de la línea xifoumbilical; muy sensible en la úlcera activa

si es muy sensible, indica

La úlcera activa se confirma con endoscopia y biopsia

cierra el píloro y da (→ 4 · Síndrome pilórico)

también favorece la (→ 5 · Literatura: H. pylori y linfoma MALT)

si cicatriza y retrae (→ 3 · Complicaciones de la úlcera)

si alcanza un vaso (→ 3 · Complicaciones de la úlcera)

si atraviesa la pared (→ 3 · Complicaciones de la úlcera)

3 · COMPLICACIONES DE LA ÚLCERA

Cicatrización F5
la retracción cicatrizal (o un tumor) cierra el píloro

Hemorragia digestiva alta F4
la úlcera alcanza un vaso: complicación más frecuente (hematemesis y melena)

se localiza con

Endoscopia: localizar y controlar el vaso (lámina 21)

Perforación F3
el jugo gástrico cae al peritoneo; duodenal 8 veces más frecuente que gástrica, varones 4-5 : 1

la contractura da

Abdomen en tabla
dolor súbito y contractura; aire libre bajo el diafragma (neumoperitoneo)

exige

Sospecha de perforación: urgencia quirúrgica, sin bario

4 · SÍNDROME PILÓRICO: ESTÓMAGO QUE NO SE VACÍA

Síndrome pilórico F5
estómago que no se vacía por cierre del píloro (cicatriz de úlcera o tumor)

por plenitud da

por retención da

Saciedad precoz F5
plenitud por retención gástrica

por contracción da

Vómito de retención F5
alimentos de 8 horas o más, sin bilis; el obstáculo está antes de la ampolla de Vater

al sacudir el epigastrio

Ondas peristálticas visibles F5
en el epigastrio, de izquierda a derecha (imagen 3)

junto al vómito apunta al

Bazuqueo (🔁) F6 · F7
deprimir el epigastrio varias veces: chapoteo de líquido y gas en estómago distendido

orienta a buscar

localizan el

confirma la

Lejos de las comidas sugiere retención gástrica: buscar el obstáculo con bario o endoscopia

5 · LITERATURA: H. PYLORI Y LINFOMA MALT

H. pylori (🔁) F13
gastritis crónica que estimula el tejido linfoide de la mucosa

si el linfoide prolifera

Linfoma MALT gástrico (🔁) F13
clon de linfocitos B tumoral; dispepsia, hemorragia, hepatoesplenomegalia

se acompaña de

Síntomas B F13
fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso mayor del 10 %

apoyan el diagnóstico de

se confirma con

Se confirma con biopsia gástrica y de médula

síntoma · desenlace · ejemplo · mecanismo · síndrome · signo · concepto · complicación · técnica · causa · diagnóstico · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Sotomayor, Semiología 2020 (09a, 09c, 09f) — teoría del docente (🔁 = literatura)